

CAPÍTULO 12.2

Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC)

PERFIL EUNACOM 1.10.2.003
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Traumatismo Craneoencefálico (TEC) y Trastornos del Sueño

TEC

Clasificación: Simple vs. Severo

TABLA 12.2.1: TEC SIMPLE VS TEC SEVERO	
TEC SIMPLE	TEC SEVERO
Sin signos de alarma	Con al menos un signo de alarma
Manejo: Paracetamol + alta + "vuelva si..."	Manejo: TAC + medidas de neuroprotección

Signos de Alarma del TEC

- Compromiso de conciencia **tardío** (no el inmediato — ese es normal)
- Convulsiones (que no sean inmediatas al golpe)
- Dolor muy intenso
- Vómitos explosivos/abundantes
- Signos focales
- **TEC abierto:** otorraquia (agua por oído) o rinorraquia (agua por nariz) = LCR
- **Signos de fractura de cráneo:**
 - Signo de Battle: equimosis retroauricular
 - Ojos de mapache: equimosis periorbitaria
 - Otorragia (sangre por el oído)
- **Edad < 2 años o > 65 años** → siempre manejo como TEC severo

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Concusión (conmoción cerebral): pérdida de conciencia/amnesia/convulsión **inmediatamente** post-golpe → NO es signo de alarma → alta con paracetamol. Si dura > 15 min → sí es alarma.

Medidas de Neuroprotección (TEC severo)

- **TAC** sin contraste (cerebro + cráneo o "ventana ósea")
- Oxígeno
- Anticonvulsivantes SOS
- Normotermia (tratar hipertermia)
- Normoglicemia
- Presión arterial < 220/120

Complicaciones y su imagen en TAC

TABLA 12.2.2: COMPLICACIÓN VS QUIÉN			
COMPLICACIÓN	QUIÉN	INTERVALO LÚCIDO	IMAGEN TAC
Hematoma subdural	Adulto mayor	Largo (horas-días)	Semiluna
Hematoma epidural	Jóvenes/niños	Breve (minutos-1 hora)	Biconvexa
Contusión cerebral	Cualquiera	Variable	Zona hiperdensa frontal/occipital
Lesión axonal difusa	Cualquiera	No hay	TAC normal + coma → pronóstico muy malo

EUNACOM CRITERIOS

Hematoma subdural y epidural → tratamiento quirúrgico (drenaje). Solo si hay enclavamiento.

Hemorragia Subaracnoidea post-TEC

- Sangre en las cisturas cerebrales (imagen en estrella blanca o bañando el mesencéfalo)
- Complicación del TEC o ruptura de aneurisma (espontánea)

Trastornos del Sueño

Insomnio

TABLA 12.2.3: TIPO VS DEFINICIÓN	
TIPO	DEFINICIÓN
De conciliación	Dificultad para quedarse dormido
De mantención	Se despierta en mitad de la noche
De despertar precoz	Se despierta demasiado temprano

Tratamiento del insomnio

- **Primera línea:** higiene del sueño + **terapia cognitivo-conductual** (TCC)
- **Fármacos** (solo si insomnio grave, refractario, por breve tiempo — máx 2 semanas):
 - **Hipnóticos Z:** zopiclona, zolpidem, eszopiclona → menos efectos adversos → **elección en adulto mayor**
 - Benzodiacepinas: alprazolam, clonazepam, diazepam → más efectos adversos, riesgo de dependencia
 - Melatonina (menos eficaz, útil en alteraciones del ciclo circadiano — jet lag, turnos nocturnos)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Benzodiacepinas = riesgo de adicción. Indicar por el menor tiempo posible. En adulto mayor → preferir hipnóticos Z.

Narcolepsia — Tétrada

- **Hipersomnia diurna irresistible** (ataques de sueño) — más importante
- **Cataplejía** (pérdida súbita del tono muscular desencadenada por emociones)
- Parálisis del sueño (se despierta consciente pero inmovilizado)
- Alucinaciones hipnagógicas (al dormir) / hipnopómpicas (al despertar)

NOTA CLÍNICA

Puntos 3 y 4 pueden ocurrir de forma aislada en personas normales. Solo son patológicos en contexto de narcolepsia.

Síndrome de Piernas Inquietas

- Disestesias + movimientos involuntarios de piernas al dormir
- **Tratamiento:** hierro (si ferritina baja) + agonistas dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol)

Pesadilla vs. Terror Nocturno

TABLA 12.2.4: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	PESADILLA	TERROR NOCTURNO
Sueño	REM	No REM
Se despierta	Sí, asustado, recuerda el sueño	Sí, grita, llora — pero no recuerda al día siguiente
Frecuente en	Cualquier edad	Niños
Conducta	Educación, manejar estrés	Educación a los padres (es normal)

SAHOS (Síndrome de Apnea/Hipopnea Obstructiva del Sueño)

- Causa de hipersomnia secundaria (no duerme bien → somnolencia diurna)
- Tratamiento: baja de peso + CPAP

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Niño de 8 meses se cae de la cama y presenta un hematoma en la región frontal. No tiene compromiso de conciencia ni otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- TEC simple (sin signos de alarma) = paracetamol + control SOS. TEC severo (con signos de alarma) = TAC sin contraste + neuroprotección + manejo complicaciones.
- Signos de alarma: compromiso de conciencia tardío, convulsiones, dolor intenso, vómitos explosivos, signos focales, TEC abierto (otorraquia/rinorraquia), fractura de cráneo (Battle/mapache/otorragia), edad <2 o >65 años.
- Compromiso de conciencia, amnesia o convulsiones INMEDIATAS post-TEC NO son signos de alarma (concusión cerebral, buen pronóstico). Solo si duran >15 min.
- Hematoma subdural: adulto mayor, venoso, intervalo lúcido largo (horas-días), TAC en semiluna. Hematoma epidural: jóvenes, arterial (menínea media), intervalo lúcido corto (minutos), TAC biconvexo.
- Lesión axonal difusa: coma + TAC normal = pronóstico muy malo (muerte, estado vegetativo o secuelas graves).
- TEC abierto (otorraquia/rinorraquia) tiene riesgo de meningitis y requiere antibióticos.
- Ambos hematomas (subdural y epidural) requieren manejo quirúrgico por síndrome de hipertensión endocraneana.
- Hemorragia subaracnoidea post-TEC: sangre en cisternas cerebrales, imagen característica en TAC.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO (TEC))**PREGUNTA 1**

Niño de 8 meses se cae de la cama y presenta un hematoma en la región frontal. No tiene compromiso de conciencia ni otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Alta con paracetamol y control SOS
- B)** Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- C)** Observación hospitalaria por 24 horas sin imágenes
- D)** Solicitar radiografía de cráneo
- E)** Solicitar resonancia magnética de cerebro

PREGUNTA 2

Paciente de 25 años sufre TEC en accidente de bicicleta. Pierde conciencia inmediatamente por 30 segundos y luego se recupera completamente. Una hora después presenta compromiso de conciencia progresivo. ¿Cuál es la complicación más probable?

- A)** Concusión cerebral prolongada
- B)** Hematoma subdural agudo
- C)** Hematoma epidural
- D)** Lesión axonal difusa
- E)** Contusión cerebral frontal

PREGUNTA 3

Paciente con TEC presenta otorraquia (salida de líquido claro por el oído). Además de las medidas de neuroprotección, ¿qué conducta adicional es fundamental?

- A)** Taponamiento del conducto auditivo externo
- B)** Agregar antibióticos por riesgo de meningitis
- C)** Solicitar resonancia magnética urgente
- D)** Realizar punción lumbar diagnóstica
- E)** Iniciar anticonvulsivantes profilácticos de mantención

RESUMEN: TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO (TEC)

Esta clase aborda el manejo del traumatismo encéfalo craneano (TEC), diferenciando entre TEC simple y severo según la presencia de signos de alarma. El TEC simple se maneja con paracetamol y control SOS, mientras que el TEC severo requiere TAC sin contraste (cerebro con ventana ósea), medidas de neuroprotección y manejo de complicaciones. Los signos de alarma incluyen: compromiso de conciencia tardío, convulsiones, dolor muy intenso, vómitos explosivos abundantes, signos focales, signos de TEC abierto (otorraquia, rinorraquia), signos de fractura de cráneo (signo de Battle, signo de mapache, otorragia), y edad extrema (menor de 2 años o mayor de 65 años). Es fundamental distinguir que el compromiso de conciencia, amnesia o convulsiones inmediatamente después del TEC no son signos de alarma, sino parte de la concusión o conmoción cerebral, que es de buen pronóstico. Se revisan las principales complicaciones: el hematoma subdural (adulto mayor, sangrado venoso lento, intervalo lúcido largo de horas a días, imagen en semiluna), el hematoma epidural o extradural (niños y adultos jóvenes, sangrado arterial de arteria menígea media, intervalo lúcido breve de minutos, imagen biconvexa), la contusión cerebral (lesiones frontales/occipitales, zona hiperdensa, no requiere cirugía), la lesión axonal difusa (coma con TAC normal, pronóstico muy malo) y la concusión cerebral (compromiso de conciencia inmediato post-TEC, buen pronóstico, se maneja como TEC simple). Se incluyen imágenes de TAC características: hematoma subdural en semiluna, hematoma epidural biconvexo, y hemorragia subaracnoidea con sangre en cisuras cerebrales y zona basal del cerebro.